



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : منال عبدالرحمن حسن علي

العنوان : 6 الشيخ طاهر
الجزائري-منيه السيرج

المحافظة : القاهرة
الحي / المدينة : الساحل

تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

رقم البطاقة : 26003070104447 رقم التليفون : 01202566558

العمر(تاريخ الميلاد) : 07-03-1960 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) قسم العلاج
الاورام [14153]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منال عبدالرحمن حسن علي National ID: 26003070104447	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Docetaxel chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مائل
عبد الرحمن حسن علي
٦ الشيخ طاهر الخازن - مدينة السبع
الساحل - القاهرة

٢٦٠٣٠٧٠١٠٤٤٤٧

١٩٦٠١٠٧٨٧

IJ4337596



Mega Scan
HAFEZ SHERIF

حافظ شريف
للأشعة والتحاليل الطبية

Patient Name: Manal Abd Elrahman	Pat. ID: 012885CHEST
	Study Date 25/07/2026
Insurance Company:	

MULTI-SLICE NON CONTRAST C.T SCAN OF THE CHEST REVEALED:

- Bilateral upper lung lobes fibrotic bands are seen associated with diffuse ground glass lung veiling, reticulonodular infiltrates as well as lower lobes thickened interstitial ?? chronic interstitial lung disease for clinical correlation and follow up.
- No evidence of focal pulmonary masses.
- No evidence of pleural or pericardial sac collections.
- No hilar or mediastinal lymph nodes enlargement.
- Normal CT appearance of the heart and its great vessels.
- Patent tracheo-bronchial tree.
-  Left breast LIQ mass lesion for sonomammography correlation.
- The scanned upper abdomen revealed no gross abnormalities.

DR. Mostafa Omara MD



Callcenter@megascancenters.com

Megascan1966

- | | | |
|------------------------------|--|--|
| Bab El Louk Branch | :180 El Tahrir St., El Falaky Square | Tel. : 27943001/ 27944430 / 01288003050 |
| Mohandseen Branch | :44 Syria St., Mohandseen | Tel. : 37625577 / 37625588 / 01288003020 |
| Giza Branch | :10 Murad St., Giza Square | Tel. : 35736460 / 35720877 / 01288003060 |
| Zayed Branch | :Twin Tower, El-Sheikh Zayed | Tel. : 37939050/ 37939060/ 01204000083 |
| (New) Zahraa el maadi Branch | :Zahrat Al-Madaen Hospital, In front of Tijan Compound | Tel. : 01278635295 / 01286743893 |



Mega Scan
HAFEZ SHERIF

حافظ شريف
للأشعة والتحاليل الطبية

:Name : MANAL ABDELRAHMAN

Date : 20/8/2026

Real time Pelvi-Abdominal Ultrasound

Liver: Average in size , with bright homogenous echopattern. There's no IHBR dilatation, No focal lesions, Main portal vein is not dilated, patent with hepatopetal flow.

Gall Bladder: not seen (surgically removed)

C.B.D. is not dilated.

Spleen: average in size (10 cm) with normal echo-pattern, splenic vein not dilated.

Central Area: No abnormalities could be detected.

Both Kidneys: Normal in site, size & shape, with good cortico-medullary differentiation, No stones, cysts or backpressure changes.

Urinary bladder:- Adequately filled, with average appearance, no stones, or diverticulae, no masses or calcifications.

Uterus: Is AVF, empty, and of average size no focal lesions

Douglas Pouch : Sonographically free.

No Adnexal Masses or cysts.

There's no evidence of free fluid collection in abdomen or pelvis.

CONCLUSION:

- Mild bright liver likely fatty for lab correlation.,

Sincerely,,,"

Dr.Kareem Hussien, MSC



Callcenter@megascancenters.com
Megascan1966

- 📍 Bab El Louk Branch
- 📍 Mohandseen Branch
- 📍 Giza Branch
- 📍 Zayed Branch

:180 El Tahrir St., El Falaky Square

:44 Syria St., Mohandseen

:10 Murad St., Giza Square

:Twin Tower, El-Sheikh Zayed

Tel. : 27943001/ 27944430 / 01288003050

Tel. : 37625577 / 37625588 / 01288003020

Tel. : 35736460 / 35720877 / 01288003060

Tel. : 37939050/ 37939060/ 01204000083

📍 (New) Zahran el mendi Branch :Tahat Al Khashan Hospital To East of Taha Center

Patient Name	منال عبد الرحمن حسن	Case No.	373598
Sex/Age	Female 66 Y	Patient No.	27822
Registered Date	09/9/2026 03:24:13 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	27/9/2026 09:34:21 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	01/10/2026 10:37:15 AM	Pathology No.	SR-1042/26

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

****Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Minr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name	منال عبد الرحمن حسن	Case No.	373598
Sex/Age	Female 66 Y	Patient No.	27822
Registered Date	09/9/2026 03:24:13 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	27/9/2026 09:34:21 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	01/10/2026 10:37:15 AM	Pathology No.	SR-1042/26

Breast Slide Revision

Clinical Data: Left breast 6 O'clock lesion (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Referred block & slides (Tru-cut biopsy).

Gross Examination:

- One referred block labelled by (203517-26). Together with, four referred slides including 1 (H&E) stained slide and 3 immunostained slides for (ER, PR & Her2).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade: 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 1).
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Angioinvasion: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * Microcalcification: Present.
- * Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

IPT:

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 40% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:

Left breast mass, Referred block & slides (Tru-cut biopsy):

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (8/8).
- PR: Positive (6/8).
- Her2: Positive (score 3+).

*** *Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qalema - Cairo, Egypt

PATIENT NAME: MANAL ABD ELRAHMAN HASSAN ALI

GENDER: Female

DATE : 25-Aug-2026 01:38 PM

PATIENT ID: 20226032345

AGE: 66 y

ORDER: Z497661,Z497830

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:

- Pathologically proven left IDC.

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views.
- IV low osmolar non-ionic contrast medium infusion 100 ml.
- Complementary US.

REPORT:

- Scattered fibroglandular parenchyma (ACR B).
- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed minimal symmetrical back ground parenchymal enhancement.
- **Low energy non contrast images:** left breast LIQ posterior third show spiculated high dense lesion harboring microcalcification extend beyond the lesion anteriorly. Away from the nipple about 57.5mm in CC view. Measure collectively about 31.5x25mm.
- **Recombined postcontrast images:** LIQ posterior third single mass enhancement show heterogenous mass enhancement.
- **Complementary US:** LIQ posterior third at 7:00 show irregular spiculated hypoechoic lesion, deep to the skin about 4mm.
- No right breast mass or non mass enhancement.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Nonspecific axillary LNs on both sides.
- Free left supra- & infra-clavicular regions.

OPINION:

- Left breast LIQ mass with pathological enhancement (BIRADS 6).
- No right breast pathological mass or non mass enhancement (BIRADS 1)



Pat. Name: Manal Abd El Rahman	Pat. ID: 3615534
Procedure Name: U.S Breast - Both Sides	Date: 02/08/2026

Imaging report

FOLLOW UP HIGH RESOLUTION ULTRASOUND SCANNING OF

BOTH BREASTS:

CLINICAL SUMMARY :

1st degree family history of breast cancer now presenting for screening

IMPRESSION :

LEFT BREAST: (BIRADS 4C)
Highly suspicious mass.

RIGHT BREAST: (BIRADS 1)
Normal study

RECOMMENDATION :-

further assessment with ultrasound guided core biopsy and MRI is recommended

DETAILED FINDINGS :

TECHNIQUE:

- o High Resolution Ultrasound with Color Doppler.

Both breasts were scanned in Sagittal and Transverse planes using a high frequency probe. Both breasts showed a non uniform echogenic structures with fat predominance a residual mottling notably in the upper outer quadrants of both breasts.

LEFT BREAST:

- There is hypoechoic solid lesion rounded to oval , ill defined ,lobular ,with posterior acoustic shadowing measures about 18 x23 mm at 6 o'clock. No internal vascularity could be seen.
- No evidence of malignancy.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary lymph nodes.

RIGHT BREAST:

- No suspicious cystic or solid masses, calcifications or other abnormalities are seen.
- No newly developed mass lesion, suspicious microcalcifications or other abnormalities.
- No radiological signs of malignancy.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary lymph nodes.

Thanks for your Reference,
Dr Aliaa Elghandour